

REHABILITACIÓN EN REUMATOLOGÍA

Fisioterapia en Hombro Doloroso

Lic. Cesar Borja Arenas
T.M. en Terapia Física y Rehabilitación

Presente.



Reconocer las principales características clínicas del Síndrome de Hombro Doloroso y los lineamientos para el apoyo en los programas de tratamiento fisioterapéutico.

Semana 10: Fisioterapia en Hombro Doloroso

1. Concepto
2. Biomecánica
3. Signos y síntomas
4. Etiología
5. Factores de riesgo
6. Evaluación
7. Programa de tratamiento
8. Métodos y técnicas fisioterapéuticas





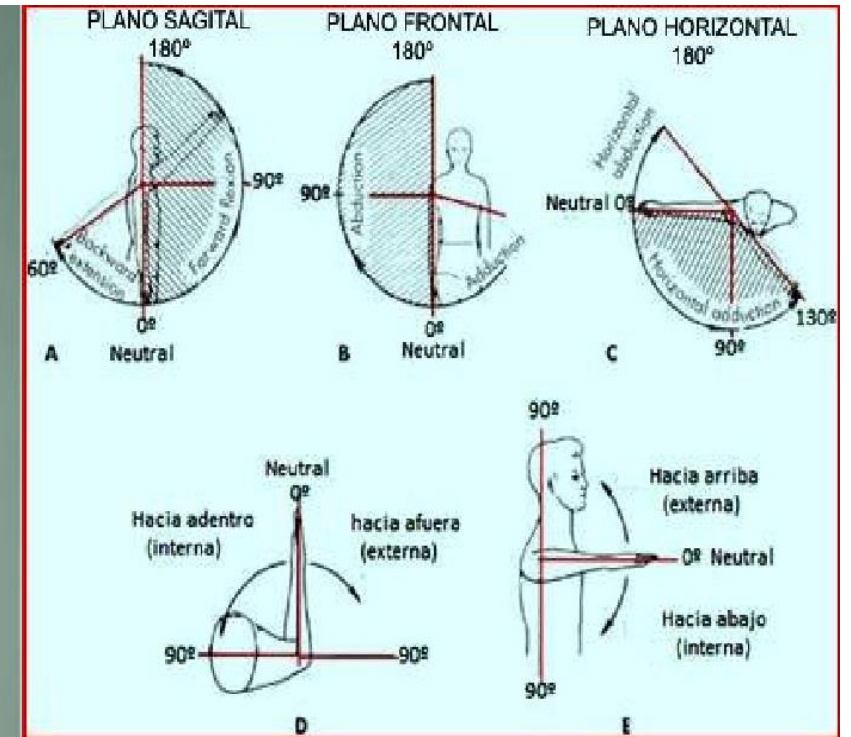
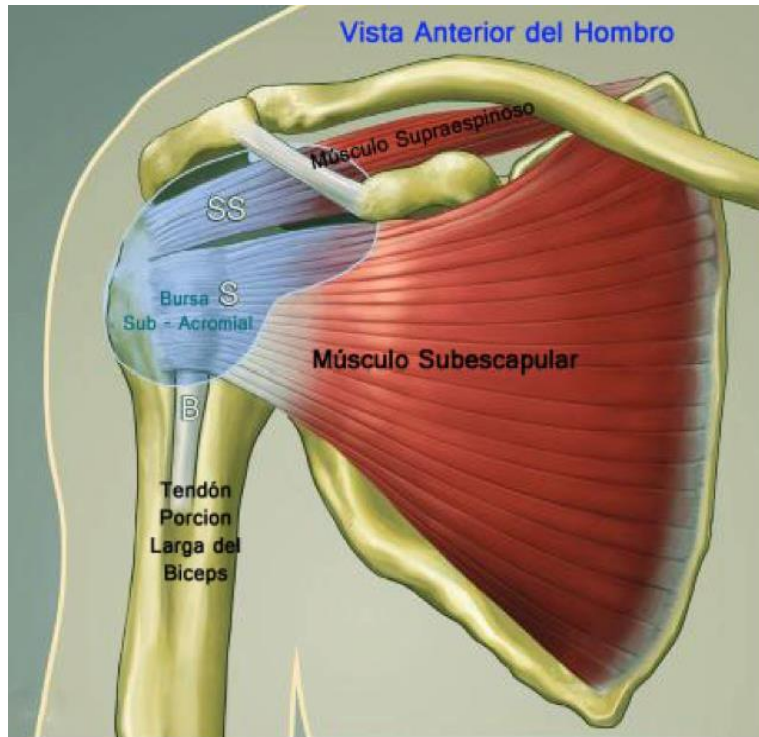
“Síndrome o grupo de cuadros que se caracterizan por el dolor y limitación del movimiento del hombro, ya sea por causas articulares, periarticulares o referidas”

Uno de los cuadros del aparato locomotor **más comunes** en Atención Primaria.

Aunque puede deberse a diversas patologías, usualmente está más ligado a tendinopatías del **manguito rotador**.

Debe recordarse que el hombro es la articulación con mayor movimiento e **inestabilidad** del cuerpo.

La **apropiada anamnesis** y **exploración física** nos permiten identificar la casuística y los objetivos a alcanzar.



VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=9_mhQWvg7ZM



Dolor

- Dolor **localizado** con **posible irradiación** hacia la zona cervical o escapular.
- Puede acompañarse de **tumefacción** de la zona o **inflamación**.
- **Punzante** y **tensional** principalmente.



Disminución de movimiento

- Debido al **dolor**.
- La **musculatura debilitada** puede influir en la disminución de rango.
- Los **procesos articulares** también pueden generar **rigidez**.



Cambios en el tono muscular

- Usualmente existe un **mayor tono** de **musculatura movilizadora** (pectoral, bíceps, trapecio, etc.).



Limitación funcional

- Debido a los síntomas previos, la **función del miembro superior decae**.
- Si el proceso perdura pueden aparecer **factores psicosociales** (kinesiofobia, **hiper** vigilancia, etc.).

Periarticular

- Tendinopatías y desgarros del manguito rotador, bíceps, pectoral y deltoides
- Patologías de bursa (bursitis): subacromial, subdeltoidea
- Patología articular: síndrome acromioclavicular y coracobraquial

Articular

Posturas mantenidas (laboral)

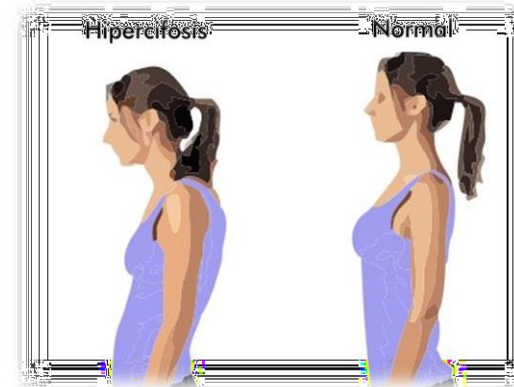
Excesiva carga mecánica

Movimientos repetitivos

Posturas y desalineamientos

Exposición a vibraciones

Debilidad muscular - sedentarismo



Evaluación médica



Radiografías (deformidades, espacio articular, etc.)



Resonancia magnética y ecografías (tejido blando).



Clínica (signos y síntomas)

Evaluación fisioterapéutica



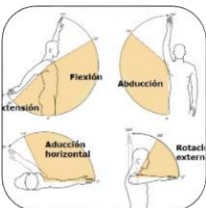
Anamnesis enfocada a conocer los antecedentes sociodemográficos, clínicos, la historia natural del cuadro, actividades y expectativas del paciente.



Inspección de la postura (deformidades o asimetrías), zona de dolor (inflamación) y las características de la piel.



Valoración de las características del dolor (intensidad, localización, factores desencadenantes, factores mitigantes, tiempo, etc.).



Exploración de los rangos de movimiento del hombro (extensión hasta 50°, flexión 180°, abducción 180°, aducción hasta 45°, rotación interna/externa 90°)

Evaluación fisioterapéutica



Exploración de la fuerza muscular en los movimientos de hombro (escala de Daniels).



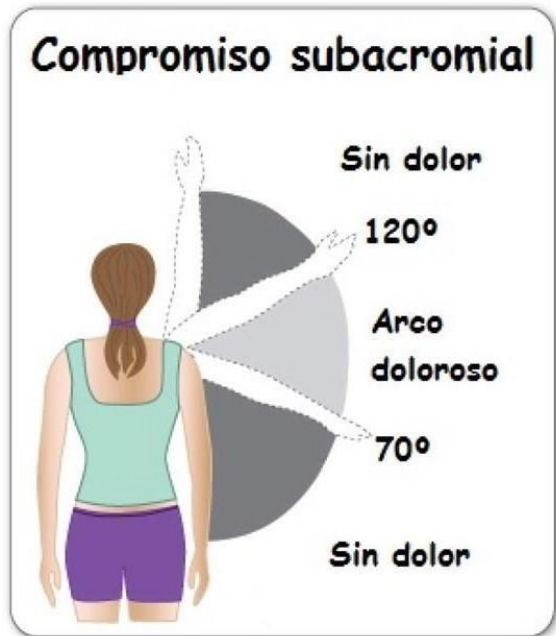
Palpación de zonas/estructuras dolorosas (musculatura, tendones, ligamentos y prominencias óseas).



Medición de la capacidad funcional según cuestionarios, índices o escalas.



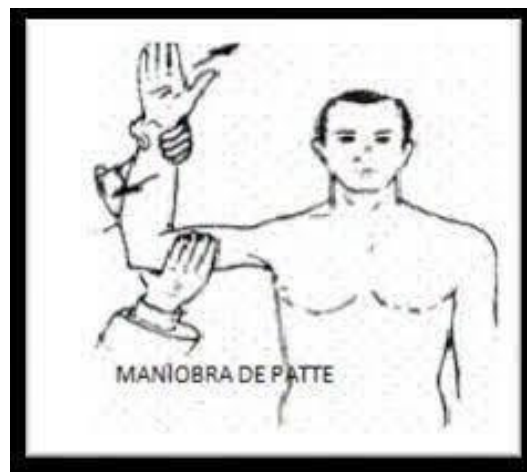
Valorar la presencia de síntomas psicológicos como el miedo, la ansiedad, la depresión, entre otros.



Supraespinoso



Maniobra de Yergason:
bíceps braquial.



Infraespinoso y
redondo menor

Maniobra de Gerber
(o Lift-off Test)



Subescapular

Disminuir el dolor e inflamación

Incrementar la flexibilidad y rango de movimiento

Aumentar la fuerza muscular

Mejorar la funcionalidad del segmento

Disminuir
dolor e
inflamación

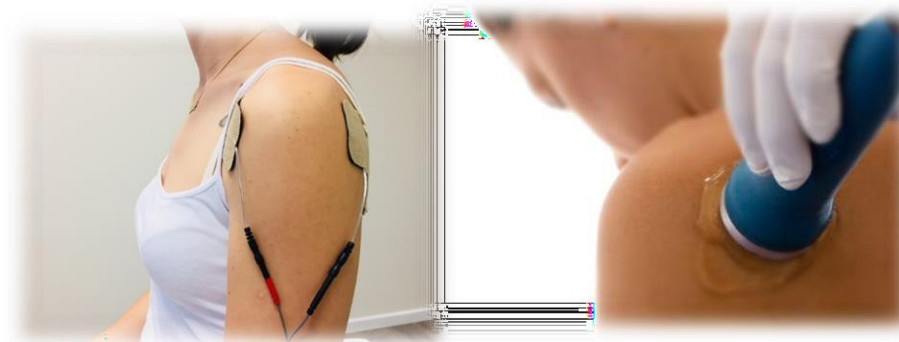
Termoterapia (CHC, IR)
sobre musculatura
comprometida

Electroterapia analgésica
sobre puntos dolorosos

Ultrasonido o terapia
combinada sobre puntos
tendinosos

Crioterapia sobre puntos
tendinosos, ligamentosos
e inflamación

Magnetoterapia sobre
zona afectada (antero-
postero humeral)



Incrementar
la flexibilidad
y rango de
movimiento

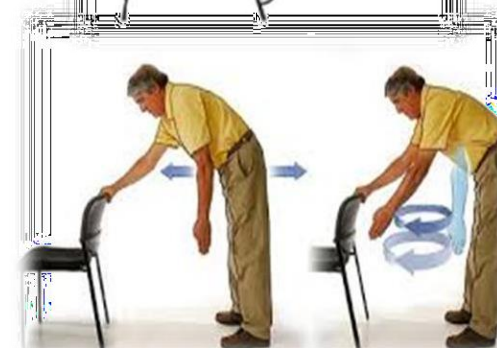
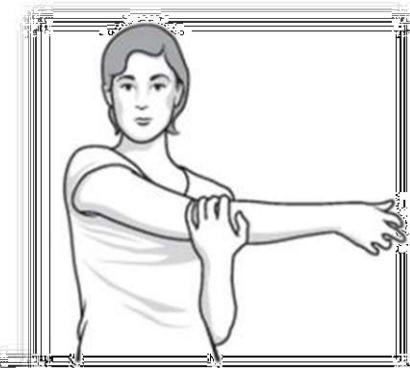
Masoterapia en
vientres musculares
afectados

Movilizaciones activo-
asistidas (ritmo
escápulo humeral)

Estiramientos
osteomusculares para
cintura escapular

Movilizaciones
articulares gleno
humerales

Ejercicios pendulares



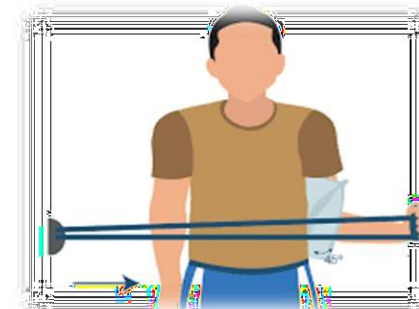
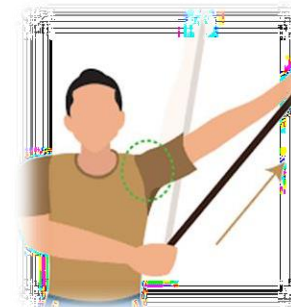
Aumentar la fuerza muscular

Ejercicios isométricos
para manguito rotador

Ejercicios libres para
todos los movimientos
de hombro

Presente.
Ejercicios resistidos
para manguito rotador
con bandas o pesas

Carga progresiva de
peso sobre el hombro
lesionado

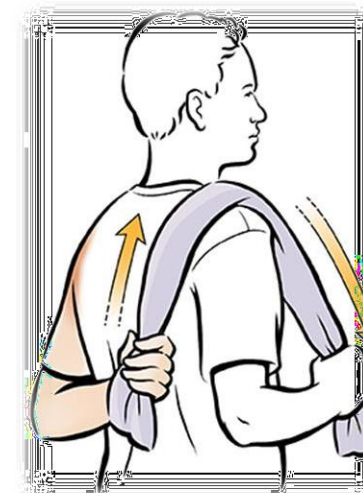


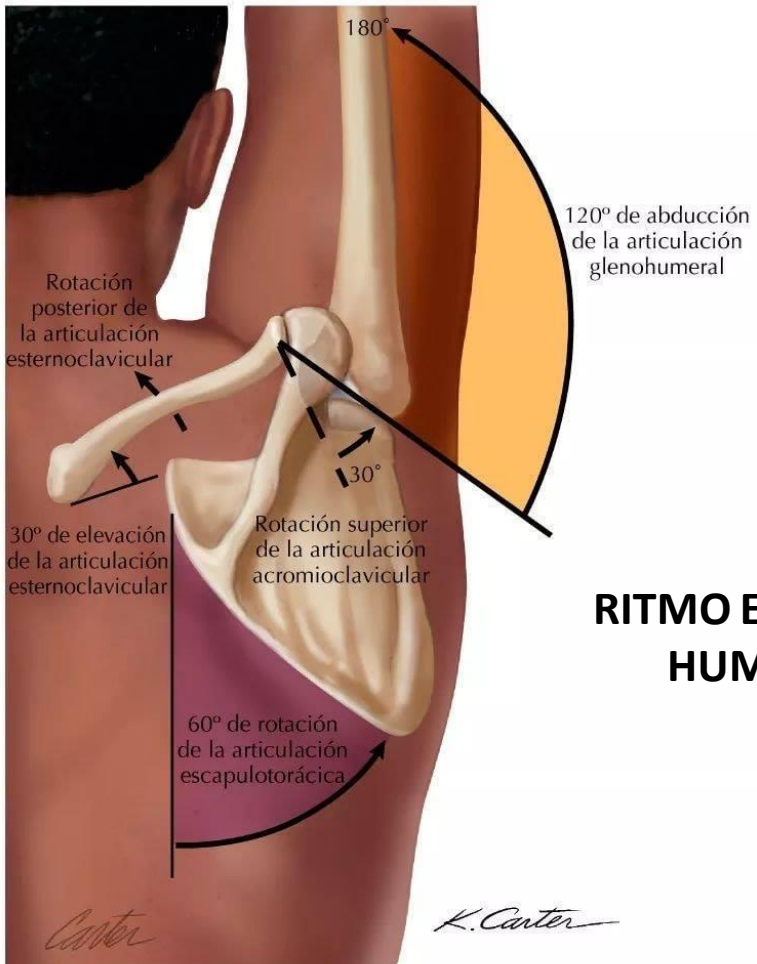
Mejorar la
funcionalidad
del segmento

Ejercicios para
estabilizar cintura
escapular

Actividades
cotidianas y
laborales

Alcances con
apoyo sobre
hombro lesionado





RITMO ESCAPULO HUMERAL

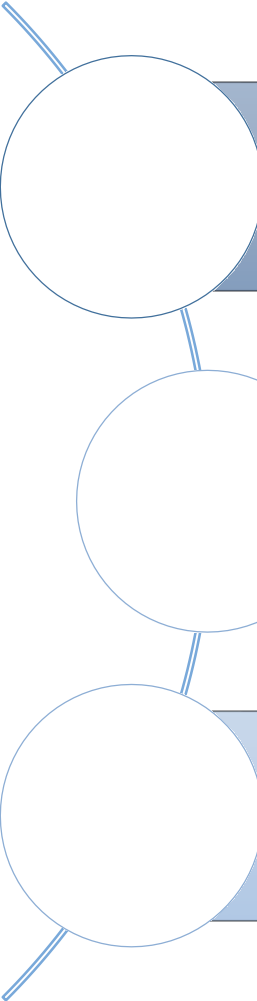


CHANDLER



CODMAN

VER VIDEOS: <https://www.youtube.com/watch?v=NBrn1V7POJk> - https://www.youtube.com/watch?v=jlarmgJFn_E



1. EL HOMBRO DOLOROSO SE CARACTERIZA POR UN DOLOR LOCALIZADO EN LA REGIÓN DEL HOMBRO Y SUS PRINCIPALES SÍNTOMAS SON DOLOR PUNZANTE, DISMINUCIÓN DEL MOVIMIENTO Y MUSCULATURA DEBILITADA CON POSIBLE INFLAMACIÓN.

2. LOS FACTORES DE RIESGO DEL HOMBRO DOLOROSO PUEDEN SER LAS POSTURAS MANTENIDAS, EXCESO DE CARGA, DEBILIDAD MUSCULAR Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS.

3. EL HOMBRO DOLOROSO ES UNA PATOLOGÍA MUY FRECUENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA Y REQUIERE DE UN TRATAMIENTO OPORTUNO FISIOTERAPÉUTICO PARA DISMINUIR LOS SÍNTOMAS Y MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DEL PACIENTE.

- https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v62n245/06_inspeccion.pdf
- https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152013000100009
- <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/085GRR.pdf>
- <https://scielo.isciii.es/pdf/medif/v13n3/notacli3.pdf>
- <http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v27n2/v27n2a08.pdf>
- <https://svmeifr.com/wp-content/uploads/2021/10/HOMBRO-DOLOROSO.pdf>

Presente.

PREGUNTAS ACLARACIONES INTERVENCIONES



Realiza una infografía sobre el hombro doloroso haciendo hincapié en dos ejercicios de flexibilidad y dos ejercicios de fortalecimiento según el grupo muscular afectado (1. Tendón del bíceps braquial; 2. Tendón del supraespinoso; 3. Tendón del subescapular y 4. Tendón del infraespinoso/redondo menor).



MUCHAS GRACIAS

Presente.